
腹腔感染
☆☆☆
（0~1题）
腹膜解剖
①壁腹膜（体神经支配）：定位准确、腹膜刺激征、改变体位时疼痛加剧（2007）
②脏腹膜（自主神经支配）
继发性腹膜炎
多继发于腹腔空腔脏器穿孔损伤，多为混合性感染（大肠杆菌、厌氧菌多见）
腹痛：持续剧烈（原发部位最显著，2007）
标志体征：腹膜刺激征（压痛、反跳痛、肌紧张，2007、2020）
毒素入血：发热、脉快
病情恶化“凉了”：腹胀加重、脉快但体温↓、腹水炎细胞↑（2010）
半卧位：减少毒素吸收、利于引流、利于呼吸循环
膈下脓肿
发热、上腹痛、呃逆、膈肌抬高、胸膜炎
首选 B 超
盆腔脓肿
多继发于阑尾炎、腹盆腔手术后
发热、肛门下坠感、直肠刺激征（里急后重）和 / 或膀胱刺激征（尿频尿急尿痛）
首选直肠指检：直肠前壁有触痛的波动性肿块
直肠前壁或阴道后穹窿穿刺后切开引流、三代头孢 + 甲硝唑